内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·肺结核

（性感认识：变态反应和免疫力常同时发生）→ 决定了原发性肺结核还是继发性肺结核更容易出现空洞

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、临床表现

1.**发热最常见**

（1）多为长期低中热，尤其午后**低热**

《诊断学》：低热 37.3-38 度、中热 38.1-39 度、高热 39.1-41 度、超高热＞41 度

慢性低热：结核、支原体肺炎、淋巴瘤等肿瘤、风湿疾病、吸收热（肝硬化门静脉血栓形成等）

不发热或低中热 不发热或低中热 eg.急性心梗坏死物的吸收、盆骨骨折/股骨干骨折的血液吸收

看到高热不会优先考虑结核，但也不能排除

（2）结核毒血症状严重时可有高热，如大叶性干酪性肺炎、急性粟粒性肺结核（全肺广泛三均匀粟粒影），此时可用 ttsx 糖皮质激素（原则：早期足量短程+有抗结核药的情况下）短期结核杆菌大量入血

抗炎不抗菌，提高对伤害刺激的耐受 长期副作用大

2.常有咳嗽咳痰：多为干咳少痰，形成空洞→痰量增多，合并其它感染→脓痰

呼吸系统中看到咯血要想到支扩、结核、肺癌

3.常有**咯血**

病理学中：血管瘤和淋巴管瘤都属于脉管瘤（良性肿瘤，浸润性生长）

→这里的血管瘤应是动脉瘤（血液冲击鼓出来一坨）

（1）多为**痰中带血**（少量咯血）：与毛细血管扩张、通透性增高相关

（2）支气管动脉损伤或空洞血管瘤破裂→咯血量多 支气管动脉：支扩（破坏支气管壁） 支气管静脉：二狭（左心衰）

（3）咯血后发热可能是：①结核杆菌播散（低中热）；②血块吸收致吸收热（低中热）；③血块阻塞支气管致阻塞性肺炎（低中热）；④合并其它感染（可高热）

同一部位反反复复出现肺炎

4.常有**盗汗**、乏力、**体重减轻**等 结核是消耗性疾病

慢慢破坏

5.可有胸痛（结核病灶累及壁层胸膜）：多不剧烈；可有呼吸困难（大叶性干酪性肺炎、较多胸腔积液等）结核性腹膜炎：揉面感柔韧感 VS 一般消化性溃疡导致的腹膜炎：板状腹，硬

6.可有**结核性风湿症**：青少年女性多见，多累及四肢**大关节**，受累关节附近的皮肤间歇出现**环形红斑或结节性红斑**

VS 类风湿：累及小关节

结节病也可有结节性红斑、关节炎

7.体征取决于病变性质和范围

①病变范围较小→无任何体征

语音震颤增强：实变、空洞、胸腔积液的上方，可以闻及异常的支气管呼吸音或异常的支气管肺泡呼吸音

②病变范围 ttsx 较大的渗出、坏死→实变体征（浊音或实音、湿啰音、语音震颤↑、异常支气管呼吸音或异常支气管肺泡呼吸音）传导增强

③病变范围较大的纤维条索→患侧胸廓塌陷、纵隔向患侧移位 eg.慢性纤维空洞型肺结核

④较多的胸腔积液→患侧胸廓饱满、纵隔向健侧移位、浊音或实音、呼吸音减弱或消失

⑤支气管结核→局限性哮鸣音 VS支气管哮喘：小气道的痉挛导致广泛哮鸣音

肺癌也可有

可能可能最可能：**长期低热，多盗汗、咯血，上肺特别是肺尖、锁骨区**

上肺病变优先考虑结核 VS 结节病：病变多侵犯上叶